

Не просто накормить

Не просто накормить: вариативное питание в домах социального обслуживания

Полный письменный доклад к дискуссии 26.08.2026

Автор: Чистяков Евгений Владимирович, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

Со-модератор сессии: Нурбаев Тимур Аликович, директор СПб ГБСУСОН «ДСО „Тесовый берег“»

Семинар «Пространство Новых Идей 2.0» · Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 · Минтруд России

Площадка № 2, 14:00–15:30 · «Организация питания: опыт реализации проектов»

Сверка фактов: 24.08.2026. Статусы утверждений — в [FACTCHECK.md](#). Источники — в [BIBLIOGRAPHY.md](#).

Это справочник для внедрения, не конспект 90 минут. Документ не является нормативным актом, клиническим руководством и не заменяет юридическое заключение. Шаблоны в проект/appendices/ — **проекты** локальных форм.

Блок I.1. Вступление и резюме (разделы 1–4)

Рамка: от конфликта за одним столом к системному решению.

1. Вводная сцена: тихий стол

Я — Чистяков. Мы сегодня в доме Тимура Нурбаева. У него контур 44-ФЗ, у меня — 223-ФЗ. Один учредитель, разные кухни закона. Не путать.

Начну не с витрины.

В зале всегда находится человек, которому шум чужой ложки — уже событие. Он отодвигает тарелку не потому, что «капризничает». Он отодвигает её, потому что за этим столом слишком много чужих решений: кто сел рядом,

какая каша, успеет ли сиделка, остынет ли борщ, пока очередь дойдёт до тех, кого кормят с ложки.

Собирательная картина — не протокол одного обеда и не отчёт комиссии. Средний взрослый ПНИ в расчёте проекта «Если быть точным» — порядка 289 мест [исследование, агрегат 2024]. Линия — одно блюдо на позицию. Часть людей ест только с помощью. Смена считает минуты.

Пять конфликтов сходятся в одном часе:

1. **Очередь против помощи.** Самостоятельным раздали первыми — так быстрее. Тем, кого кормят, еда остывает. Нормы «не больше двух полностью кормимых на работника» у нас в законе нет. Это ориентир чужой системы, не наша обязанность. Но именно здесь рождаются недоедание и аспирация «на скорость».
2. **«Он опять не ест кашу».** Третий день отодвигает тарелку. Журнала отказов нет — или он ведётся к комиссии. Врач узнает в четверг. За отказом может стоять депрессия, дисфагия, протест, боль. Без записи это всё одно и то же: «каприз».
3. **Кофе и клоzapин.** Родственники принесли крепкий кофе. Кухня не «отменяет кофе». СУР1А2 — зона врача. Но если на посту нет таблицы «лекарство × еда», вечером седацию спишут на «плохой день».
4. **Добавка без назначения.** Человек на весогенном антипсихотике просит вторую котлету. Сиделка отказывает «для пользы». Врачебного ограничения нет. Это уже не питание — это самодеятельность.
5. **Журналы «в порядок».** Комиссия в четверг. Пробы за вчера подпишут сегодня. Для проверяющего это не «бумаги отстали» — это имитация контроля. Ст. 6.6 КоАП смотрит качество и безопасность организации питания, не «два вторых».

Ни один из пяти конфликтов сам по себе не лечится вторым блюдом. Если фундамент дырявый, вариативность добавит шестой конфликт — и добьёт смену. Поэтому дальше — не «ресторан», а архитектура.

Через год в той же столовой женщина, которой нужно молчание, ест за тихим столом. Мужчина на клоzapине пьёт кофе, согласованный с врачом. Неговорящий показал на карточку и получил то, на что показал. Смена работает по журналам. Конфликты не исчезли — они получили процедуры.

2. Резюме для тех, у кого 15 минут

Суть. Федеральное право не запрещает выбор блюда и не обязывает его давать каждый день. Запрета нет — прямой обязанности тоже. Директору этого мало: нужна бумага, которая разрешает у вас. Клиника задаёт красные линии. Кухня держит пару эквивалентов в одной сырьевой строке. Закупка (44-ФЗ или 223-ФЗ) описывает группы продуктов, не одно блюдо.

Красные линии. Без врача: текстуры, лечебный стол, кофеин на клозапине, соль на литии, длительный отказ, зонд, конец жизни. Без учредителя: смета, штат, статус пилота, аутсорсинг. Без правовой проверки: «согласие недееспособного» в локальных актах и конструкции, где учреждение само себе опекун.

Панель чисел (чужие данные — с оговоркой; свои — замерить).

Число	Что это	Чего это не есть
74 %	Доля признанных недееспособными в агрегате по ПНИ за 2024 («Если быть точным»)	Статформа Минтруда; цифра вашего дома
21,9–69,5 %	Диапазон дисфагии в клинических работах у лиц на антипсихотиках (Miarons, 2017)	Распространённость в российских ДСО
+3,01 кг	Клозапин vs placebo за ~6 нед. (Pillinger, 2020, 100 РКИ)	Доля пациентов; не 76,3 %
76,3 %	CRWG ≥7 % массы на клозапине >38 нед. (Campforts, 2023)	Эффект вариативного меню
01.09.2026	Вступление в силу СанПиН 2.3/2.4.4282-26	Дата сессии; 26.08 документ ещё не в силе
520н	Рекомендуемые нормы Минтруда	Императив
—	Доля отходов по РФ	Не существует в публичном поле

Понедельник без новой сметы. Посчитать сырьевую строку (месяц продуктов ÷ жители ÷ дни). Запустить семидневный замер отходов и ночного интервала. Приказ о рабочей группе. Письмо учредителю. Одно отделение, один обед, одна неделя.

3. Целеполагание и границы

Центральный вопрос. Как директору дома социального обслуживания дать жителю реальный выбор еды, не ломая санитарную безопасность, клинические ограничения и контур закупки?

Тезис. Вариативное питание — не «ресторан в ПНИ» и не новая строка бюджета, а управляемая архитектура эквивалентной замены: клиника задаёт красные линии, кухня держит пару блюд в одной сырьевой строке, право фиксирует выбор (в том числе невербальный) как факт ухода, а закупка описывает пары, а не одно блюдо.

Что такое вариативность здесь. В момент приёма пищи житель имеет реальную возможность получить не менее двух равноценных вариантов и влияет на то, какой получит.

Что вариативностью не является. Цикл из 14 дней без повторов. Замена гречки на рис «по остаткам склада». «Спросите заведующую за неделю». Холодное вчерашнее как «второй вариант». Меню, которое спрашивают, но готовят одно.

Границы выводов. Пакет говорит о стационарных домах для взрослых с психическими расстройствами и ментальной инвалидностью. Детские организации, больницы и соцучреждения общего типа — аналогия с оговоркой. Эффект вариативности на отходы, вес и «счастье» в психиатрических стационарах **не доказан** рандомизированным исследованием. Пилот 90 дней отвечает на вопрос «можем ли мы это делать безопасно», не на вопрос «вариативность работает».

4. Карта документа

Восемь блоков, 44 раздела — инвентарь содержания. Устная сессия несёт **аргумент**, не все 44 стены текста.

Блок	Разделы	Зачем директору
I.1 Вступление	1–4	Сцена, 15 минут, границы

Блок	Разделы	Зачем директору
I.2 Лестница	5–8	Термины, модели, самоопределение
I.3 Клиника	9–14	Дисфагия, лекарства, отказ, гиперфагия, пика, невербальный выбор, врач
I.4 Право	15–18	Дееспособность, СанПиН как он есть, 3185-1, фиксация выбора
I.5 Кухня	19–22	Пары, линия, отходы, журналы
I.6 Контекст	23–27	РФ, мир, ошибки переноса, 520н, социология стола
I.7 Люди и деньги	28–30	Штат, сырьевая строка, 44 vs 223
I.8 Запуск	31–44	Документы, проверяющий, пилот, возражения, отрасль, достоверность, список источников

Нумерация совпадает с главами проект/chapters/ (приложенная структура руководства). Раздел 34 в исходниках — совет жителей; карта рисков — в 36; достоверность — 41; аутсорсинг — 42; заключение — 43; библиография — 44.

Блок I.2. Сцена, терминология, лестница (разделы 5–8)

5. Определения: вариативное питание и «заказное меню»

Четыре вещи, которые в зале смешивают.

Цикличное меню — повтор цикла блюд. Разнообразие во времени, не выбор сегодня.

Таблица замен — законный механизм эквивалентной замены продуктов в раскладке. Делает вариативность возможной, сама по себе выбором жителя не является.

Вариативное меню — ≥2 варианта в одной точке приёма, из которых житель выбирает.

Заказное питание — в правилах Серафимовского: житель (в том числе маломобильный) заказывает рацион накануне; выбор фиксируется. Это **наша локальная конфигурация М1**, не отраслевой термин ГОСТ.

Персонализация — индивидуальные назначения (текстура, ограничения) вне общего выбора. Её делает врач, не очередь.

6. Лестница моделей

Каждая ступень — рабочая конфигурация с ценой и рисками. Российская публичная практика закрывает М1–М2. Выше — горизонт, не «с понедельника».

Модель	Что видит житель	Цена входа	Кто уже так писал о себе
М0	Выбора нет, отказ → замена, остатки разбирают	Журнал отказов	Фундамент, не вариативность
М1	Два варианта ключевой позиции, не каждый день / не все отделения	Вторая гастрೋёмкость, журнал заказа	Болотнинский ПНИ; Серафимовский (заказ накануне, часть жителей)
М2	Два первых / вторых / салата / напитка ежедневно	Статистика выбора, пересчёт объёмов	Успенский ПНИ; заявленная модель Иркутской области
М3	Линия «собери тарелку»	Площадь, поток, открытые блюда	Выборочно; санитарный контур жёстче
М4	Семейная подача	Поведение за столом, роль смены	Данные Nijс — деменция, не ПНИ

Модель	Что видит житель	Цена входа	Кто уже так писал о себе
М5	Своя кухня	Тренинг, штат, безопасность	Квартиры навыков, не тысячник

Лестница работает вниз. Уходит инициатор → «временно» одно блюдо → журнал для проверки. Признак регресса: падает доля выбравших не-стандарт, журнал срывов пустеет.

7. Самоопределение ступени

Не верьте положению. Три вопроса к вчерашнему дню:

1. Покажите вчерашний **журнал заказа**. Нет записи — ступень не выше декоративной.
2. Второй вариант **физически стоял** на линии, когда подошёл последний из отделения?
3. Назовите жителя, который вчера получил не то, что ему принесли бы по умолчанию. «Таких нет три недели» — выбор фиктивен.

Полная форма — 03_семинарский_пакет/12_форма_ступени.md. Не изобретайте «утверждённый бланк Минтруда»: его нет.

8. Архитектура выбора

Стандартизация заканчивается там, где выполнены санитарный контур, раскладка и клиническая рамка. Человек начинается там, где внутри этой рамки есть **два равноценных пути** и способ сказать «это».

Пять критериев реального выбора: доступность, равноценность, информированность, уважение (выбранное подаётся), учёт (запись влияет на завтрашние котлы).

Сопровождаемое проживание без навыка назвать кашу — лозунг. Ступени 1–2 готовят бытовое решение. Ступень 5 — не массовая модель тысячника. В Серафимовском на февраль 2026 — порядка 1 004 проживающих [**локальная практика, архив сайта**]. Реформа всего дома одним приказом — не пилот, а авария.

Блок I.3. Клиника (разделы 9–14)

9. Дисфагия и текстуры

Факт. В клинических работах у людей, принимающих антипсихотики, распространённость проблем глотания оценивалась в диапазоне 21,9–69,5 % (Miarons, 2017) [**исследование**]. Это не аудит российских ДСО.

Интерпретация. Порядок величин достаточен, чтобы директор не считал попёрхивание «манерам».

Норма текстур. IDDSI — международная шкала 0–7 (напитки 0–4, пища 3–7), CC BY-SA 4.0. Российский СанПиН говорит языком «диетическое (лечебное) по показаниям», «протёртое» — **не** уровнями IDDSI. Не писать в локальный акт «IDDSI 5» как будто это пункт СанПиН.

Практика внедрения IDDSI. Wu et al., 2022: 5 учреждений aged care; соответствие блюд 44 % → 90 % после обучения. Pre-post, не психиатрия, не РФ. Переносим **механизм** (обучение персонала → рост соответствия), не проценты.

Красная линия. Текстуру назначает врач. Перепутанная протёртая и обычная порция — риск аспирации. Маркировка — клинический элемент, не «удобство раздачи». Поперхнулся — врач немедленно, не «дообедем».

10. Фармакокинетика и еда

Кухня не ставит диагноз. Кухня исполняет таблицу врача. Пять правил — минимум на посту.

1. Клозапин ↔ кофеин. [исследование, узкий дизайн]

Nägg, 2000: 12 здоровых некурящих мужчин, однократные 12,5 мг клозапина, кофеин 400–1000 мг/сут. Средний рост AUC 19 % (диапазон –14...+97 %), $p=0,05$. Не пациенты, не равновесная концентрация. Вывод для дома: резкие скачки кофеина (передачи, энергетики, «награда кофе») — информация врачу. Резкая **отмена** привычного кофеина тоже риск (описаны падения концентрации). Не кухня отменяет кофе.

2. Литий ↔ соль и вода. [мониторинг]

Литий и натрий конкурируют за выведение. Внезапный «малосольный стол» по инициативе кухни, жара без воды, рвота — маршрут к врачу в тот же день. Стабильность, не запрет огурцов.

3. ИМАО ↔ тирамин. [установлено в руководствах]

Редкие схемы. Выдержанные сыры, копчёности, соевый соус — по списку врача. Вариативность сохраняется **внутри** безопасного множества.

4. Грейпфрут ↔ CYP3A4. [не вешать на клозапин]

Bailey, 2013: фуранокумарины необратимо ингибируют кишечный CYP3A4. Garg, 1998: у 10 больных эпилепсией грейпфрутовый сок поднял AUC карбамазепина примерно на 41 %. **Клозапин:** Lane, 2001 — 14 дней сока, 15 пациентов, steady-state без значимого эффекта (ведущий путь — CYP1A2). Практическая рекомендация: грейпфрут не закупать в стационар вовсе — дёшево закрывает CBZ и ряд бензодиазепинов. Это не «клозапиновое» правило.

5. Алкоголь и энергетики. [рекомендация]

Алкоголь в передачах — ноль. Энергетики для клозапиновой группы = скачок кофеина.

Таблица на посту законна только с подписью врача. Приложение-проект: проект/appendices/ (лекарственно-пищевая форма). Не выдавать шаблон за утверждённый бланк.

11. Отказ от еды и протестное поведение

Отказ — не один феномен. Депрессия, дисфагия, психоз, боль, протест против режима, побочный эффект седации.

Правило трёх отказов подряд — врач сегодня. Это рекомендация пакета, не статья закона. Без неё отказ растворяется в смене.

Не насилие. Не «потом съест». Альтернатива по журналу замен. Если не ест и не пьёт — эскалация короче, особенно на литии.

Протест едой — коммуникация. Ответ процедурой, не моралью.

12. Гиперфагия, пикацизм, безопасность

Весогенные антипсихотики — факт мета-анализов (Pillinger; Campforts), не «характер». Ограничение порции без назначения врача — самодеятельность (сцена раздела 1).

Гиперфагия и ночной поиск еды: средний житель в раскладке маскирует двух разных людей. Одного перекормили, другого недокормили, среднее по отделению «в норме».

Пикацизм (непищевые предметы) — клинический и санитарный риск. Контроль доступа, не «воспитание голодом».

Добавка, ночной перекус, структурированный буфет — только в рамке врача для группы риска.

13. Невербальный выбор

Кто не говорит, всё равно выбирает: взгляд, рука, отодвинутая тарелка, устойчивый остаток одного блюда, пищевая биография.

Метод: показ двух порций (или двух карточек), пауза, фиксация. Не «угадали за него». Не тест интеллекта.

Если выбор нестабилен — это данные, не повод вернуть мономеню. Снижение способности выбирать — клинический сигнал (депрессия, седация, прогрессирование): врачу, не «перестал хотеть».

14. Психиатр и диетсестра

Клиника диктует множество, не одно блюдо. Диета — рамка. Внутри рамки — пара эквивалентов.

Диетсестра (или тот, кто ведёт раскладку) формирует перечень для выбора — так устроена публичная практика Болотнинского ПНИ. Врач подписывает ограничения и таблицу взаимодействий. Повар варит два котла. Смена предлагает и записывает.

Конфликт «врач запретил, житель требует» не решает сиделка. Возврат врачу с конкретикой.

Приказы Минздрава 330н и 395н **не** делают наш дом больницей. Лечебное питание в СОСО — по назначению врача учреждения и п. 56(11) СанПиН 4282-26 (с 01.09) / п. 7.1.11 3590-20 (до 31.08).

Блок I.4. Право и санитария (разделы 15–18)

15. Дееспособность и право на выбор

Норма. Ст. 29 ГК РФ: гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным; над ним опека. Сделки от его имени совершает опекун, **учитывая мнение**, а при невозможности установить мнение — сведения о предпочтениях.

Норма. Ст. 30 ГК РФ: мелкие бытовые сделки самостоятельно — у **ограниченно** дееспособных. Не путать со ст. 29.

Толкование. Выбор каши на линии обычно не гражданско-правовая сделка. Недееспособность не отменяет обязанности выяснять мнение (ст. 29 ГК, 48-ФЗ).

Норма. 442-ФЗ ст. 9: уважительное и гуманное отношение; информация; отказ от услуг; защита прав; участие в составлении индивидуальных программ; санитарно-гигиенические условия и надлежащий уход. Слова «достоинство» в ст. 9 нет — не дописывать.

Норма. 442-ФЗ ст. 16 п. 2: индивидуальная программа составляется **исходя из потребности гражданина** в социальных услугах. Для поставщика обязательна. Это не ежедневное меню, но это крючок: потребность в питании и уходе может быть описана.

Агрегат. 74 % жителей ПНИ в данных за 2024 признаны недееспособными; в 2022 около 99 % недееспособных были под опекой самого учреждения (~117 тыс.) [**исследование «Если быть точным»**]. Конфликт «учреждение = опекун» — массовый. Лечится прозрачными правилами, советом жителей, ежегодным освидетельствованием по ст. 43 3185-1, письмом учредителю — не усмотрением «как опекун решил».

16. СанПиН 4282-26: что можно и чего нельзя утверждать 26.08.2026

Факт, проверенный по официальному portalу. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18 утвердило СанПиН 2.3/2.4.4282-26. Опубликование: publication.pravo.gov.ru, 0001202606020084,

02.06.2026. Регистрация Минюста № 86854. Вступает в силу **01.09.2026**, действует до 01.09.2032. На день сессии документ **ещё не в силе**.

Факт. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. № 32 от 27.10.2020) применяется до **31.08.2026**.

Двойной режим, который я кладу на стол. До 31.08 — п. 7.1.11 3590-20: в организациях стационарного социального обслуживания — питание не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям. С 01.09 — п. 56 подп. 11 4282-26, та же формула по сверке правок репозитория 22.08. Подп. 12–14 — готовая продукция привлечённых предприятий ОП, пробы, бракераж. П. 62 — питьевой режим, в том числе в организациях социального обслуживания. П. 60 — **не** норма взрослых СОСО (дети).

Чего нет в СанПиН. Запрета на два варианта блюда. Обязанности давать выбор. Уровней IDDSI.

Толкование, которое я готов защищать перед проверяющим. Второй вариант проходит тот же контур: проба, температура, маркировка, журнал. Вариативность удваивает контур, не отменяет его. Если контур имитируется, два блюда удвоят имитацию.

Сентябрь. Журналы августа не переписывать задним числом. С 1 сентября — новые формы. Программа производственного контроля перепривязывается к 4282-26. Чек-лист — приложение 39 в проект/appendices/.

17. Закон 3185-1 и достоинство

Норма. Ст. 5 ч. 2: при оказании психиатрической помощи — уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства.

Норма. Ст. 37 — права и ограничения прав пациентов в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационаре.

Норма. Ст. 43 (ред. 465-ФЗ): проживающие в стационарных СОСО для лиц с психическими расстройствами пользуются правами, предусмотренными частями 2 и 4 ст. 37. Статус, не «меню на выбор».

Лишение пищи как мера воздействия не укладывается в достоинство. Это не «педагогика».

18. Невербальный выбор как юридический факт

Чтобы показ двух порций стал фактом ухода, а не анекдотом смены, нужна запись: кто, когда, что показано, что последовало, кто видел.

Это не нотариус. Это журнал заказа / пищевая карта / лист наблюдения — проекты форм в приложениях репозитория, **не** утверждённые государством бланки.

Без записи опекун-учреждение всегда «учёл мнение». С записью можно показать проверяющему путь от жеста до тарелки. ### Блок I.5. Меню, раздача, замер (разделы 19–22)

19. Пары эквивалентов и сырьевая строка

Идея в одном абзаце. Второй вариант ключевого блюда варится в том же потоке: две каши в двух котлах, одно мясо — две формы. Это не вторая кухня.

Фильтры пары: таблица замен (белок/крупы), тот же поток, предсказуемый спрос.

Рабочий набор, не меню-рецепт на всю Россию: гречка/рис/пшено/овсянка; котлета/тефтели/рыба; щи/борщ; свёкла/морковь; чай/какао — с учётом кофеиновой строки карты.

Антипары: «без всего»; «просите за неделю»; вчерашнее холодное.

Сырьевая строка. Расходы на продукты за месяц ÷ число жителей ÷ число дней. Своё число. Публичной средней по РФ нет — и я её не выдумую. При парных эквивалентах сырьё **перераспределяется**, не обязано расти. Это **гипотеза механизма**, не обещание экономии. Иллюстративный расчёт «+3–4 кг крупы при том же суммарном расходе на 30 человек» в старых главах помечен как иллюстрация: замер обязателен.

Серафимовский публично назвал оборудование и дополнительные ставки (сообщение Комитета 22.07.2025). Новосибирские дома о новых деньгах не писали. Универсального «бесплатно» нет.

20. Линия раздачи: два блюда без новой очереди

Два варианта удлиняют точку выдачи. Порядок, который держит поток:

- заказ накануне для тех, кого кормят и для маломобильных (у нас так и устроено заказное питание);
- на линии — короткая формула «сегодня А или Б», не дискуссия о жизни;
- гарантия стандартного варианта: Б может кончиться только как срыв, записанный в журнале;
- тихий стол для тех, кому шум — барьер;
- поднос в палату — не «карантинная опция», а повседневный маршрут постельных (11 % в агрегате ПНИ — постельный режим; в вашем доме — своя доля).

Помощь за столом — самая дорогая минута. Еда не подаётся, пока помощник не готов. Иначе вариативность для самостоятельных и холодная ложка для остальных.

21. Обратная связь и аудит отходов

Почему вариативность **может** снижать несъеденное: человек реже получает то, чего не ест. Это правдоподобная гипотеза. Причинных исследований в психиатрических стационарах нет. Поэтому я не называю «минус 30 %».

Что измерять семь дней до пилота и семь дней на плато (дни 30–90, не первая неделя новизны): тарелочные остатки по приёмам; кухонные остатки; доля выбравших Б, не получивших Б; отказы; время раздачи; ночной интервал.

«% выбравших» — не KPI успеха. Успех — доступность и исполнение осмысленного выбора, плюс отсутствие роста событий риска.

22. Журналы заказа и замен

Минимальный комплект, который я кладу проверяющему (проекты форм — приложения, не «бланк Роспотребнадзора»):

- положение о питании с вариативностью;
- меню с вариантами;
- журнал заказа;
- журнал замен (отказ → альтернатива, принял ли);

- пищевые карты;
- согласование / уведомление учредителя;
- санитарные журналы проб и бракеража — на **каждый** вариант.

Вариативность без журналов — имитация. Для Роспотребнадзора важны пробы, температура, бракераж, поточность — не философия выбора. Выбор защищается санитарным контуром, а не лозунгом «запрета нет».

Блок I.6. Контекст (разделы 23–27)

23. Российские практики

Правило раздела: практикой считается публичное сообщение организации или учредителя. Новость — факт сообщения, не аудит.

Кто	Что сказано публично	Модель	Чего нет в источнике
Болотнинский ПНИ, 16.08.2024	Выбор несколько раз в неделю; перечень — диетсестра	M1	Охват, отходы, невербальный выбор
Успенский ПНИ, 13.08.2024	Два вторых, два салата, два напитка ежедневно, все отделения; «страхи не подтвердились»	M2	Экономика, устойчивость 2026
Усть-Илимский ДСО, 27.09.2024	Поэтапно, сначала столовая, опрос предпочтений	M1 → M2	Полный охват
Серафимовский, 22.07.2025 + приказ № 124 от 10.03.2026	Заказ накануне для части жителей; оборудование и ставки; полный переход затруднителен;	M1, локальный акт	Панель чисел «до/после»

Кто	Что сказано публично	Модель	Чего нет в источнике
	заказное питание в правилах дома		
Иркутская область, 14.02.2025	Два первых, два вторых, гарниры	заявка на М2 региона	Первичный акт и фактический охват
ДДСОЛ МО	14-дневное меню, совет по питанию, замены с врачом	персонализация	Не строгая вариативность

Три дома из этой таблицы сидят в зале семинара. Спрашивайте коллег, не мой пересказ.

24. Международный опыт и Campforts 2023

Campforts et al., BJPsych Open, 2023, DOI 10.1192/bjo.2022.619. Мета-анализ 201 исследования. Вопрос: какая доля пациентов набирает ≥ 7 % массы (CRWG) на антипсихотиках. Клозапин дольше 38 недель — 76,3 %. Оланзапин — 36,9 %. Авторы прямо пишут: средняя прибавка маскирует тех, кто набирает клинически значимо.

Что из этого следует для стола. Вес — клинический контур. Меню не «лечит» клозапин. Ограничение порции без врача — ошибка. Ночная доступность еды и гиперфагия — к психиатру и диетсестре, не к лозунгу выбора.

Чего Campforts не измерял. Вариативное меню. ПНИ. Отходы. Достоинство. Российский СанПиН.

Прочие ориентиры — с этикеткой «чужая система»: CMS 42 CFR § 483.60 (частота приёмов, палатабельность, верхняя граница ночного интервала 14 ч в американской логике); шведский ориентир ~11 ч; IDDSI как общий язык текстур. Прямой импорт нормы запрещён логикой пакета.

25. Ошибки адаптации западных моделей в российских ПНИ

Типовые сломы:

1. Шведский стол в зале, где часть людей не выдержит шума, очереди и открытых гастрорёмок.
2. «Self-catering» в тысячнике без тренинговой квартиры.
3. IDDSI как будто это пункт нашего СанПиН.
4. Семейная подача (Nijs, деменция) на отделении с пикацизмом и гиперфагией без рамки.
5. Обещание эффекта Wu (aged care) «у нас тоже +46 п.п. соответствия».
6. Игнорирование того, что учреждение часто само опекун — этого конфликта в западных моделях supported decision-making нет в той же конструкции.

Переносим принципы (альтернатива при отказе; текстура по оценке; ночной интервал измерим; персонал обучен). Не переносим штатные нормативы и проценты.

26. Региональные меню и приказ № 520н

Норма. Приказ Минтруда от 13.09.2022 № 520н утверждает **рекомендуемые** нормы питания в стационарной форме. Не госрегистрация как НПА с общеобязательностью СанПиН. Императив появляется, когда субъект РФ принимает свои нормы постановлением.

Отсюда практика: в одном крае — рублёвый тариф и граммовка как обязательная раскладка, в другом — рекомендация плюс локальная таблица замен. Директор читает **свой** акт субъекта, не чужой слайд.

520н не запрещает пары эквивалентов: он задаёт продуктовые группы. Пары живут внутри группы.

27. Социология стола

Жители ждут предсказуемости и уважения. Родственники ждут «как дома» и одновременно «чтобы не толстел / ел». Смена ждёт, чтобы линия не встала. Учредитель ждёт отсутствия скандала и представления прокуратуры.

Эти ожидания не совпадают. Процедура важнее лозунга: показ меню, журнал, правило добавки, регламент передач, совет жителей.

«Популярное, но не самое полезное» — мы сами так сказали про наш эксперимент в новости Комитета. Это предел, не провал: врач задаёт рамку, внутри рамки выбор остаётся.

Блок I.7. Люди и деньги (разделы 28–30)

28. Персонал: кухня и санитары

Вариативность добавляет секунды на линии и строки в тетради. Не добавляет автоматически ставок — пока вы на М1 одного отделения.

План ФТ, который я защищаю как рекомендацию:

- раздача: кто предлагает А/Б, кто ведёт журнал;
- кухня: кто варит пару, кто маркирует, кто отбирает вторую пробу;
- пост: кто эскалирует три отказа и попёрхивание;
- маломобильные: конкретный помощник на кормимого, еда не уезжает вперёд помощи.

Помощь за столом дороже крупы. Оптимизация сырьевой строки при голодном недокормленном — бухгалтерская иллюзия.

Серафимовский назвал дополнительные ставки при расширении. Пилот на 20–35 человек одной смены — другой масштаб. Не путать.

29. Финансы: экономика эквивалентной замены

Почему это **не обязательно** требовать новой продуктовой сметы: гречка и рис — одна группа; два котла — не два меню на разные деньги.

Почему это **может** стоить: гастрೋёмкости, маркировка, минуты смены, обучение, при полном охвате тысячника — оборудование и люди (наш публичный опыт).

Полная стоимость обеда всегда больше сырьевой строки (труд, энергия, списание, логистика). Нормируя только граммовку, управляем меньшей частью.

Картели на соцпитании бьют по строке сильнее второго блюда. Директор не следовательно, но устойчивый рисунок одних и тех же «победителей» — повод для учредителя и УФАС. Цифры конкретных дел ФАС в этом пакете не пересказываю без повторной выгрузки первоисточника 24.08; принцип оставляю.

30. Госзакупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ

Я веду автономное учреждение. Контур 223-ФЗ и положение о закупке. Тимур Нурбаев ведёт бюджетное — 44-ФЗ. Один Комитет, разные процедуры. Не советовать ему «как у нас в 223». Не просить у меня «извещение как в 44».

Общее:

- объект закупки — группы взаимозаменяемых продуктов, не монополия «гречка и больше ничего»;
- пропорции внутри группы — по статистике выбора, с правом корректировки;
- недоставка — эквивалент из той же группы актом;
- качество, значимое для текстур (фарш, помол), — в спецификации;
- при аутсорсинге вариативность, которой нет в ТЗ, от комбината не придет.

Антимонополия: товарный знак без «или эквивалент», «опыт работы именно с нашим домом» — риск ограничения конкуренции. Юрист контрактной службы, не директор в одиночку.

Блок I.8. Документы, риски, стратегия (разделы 31–44)

31. Комплект документов для локального запуска

1. Приказ о рабочей группе / пилоте.
2. Положение о питании (вариативность, невербальный выбор, запрет пищи как наказания).

3. Меню с парами.
4. Журналы: заказ, замены, отказы, пробы, бракераж.
5. Пищевые карты и таблица «лекарство × еда» с подписью врача.
6. Письмо учредителю.
7. Паспорт второй гастрорёмкости (поточность, температура, маркировка, проба).
8. Регламент передач и буфета.
9. С 01.09.2026 — перепривязка ППК к 4282-26.

Шаблоны: проект/appendices/app_01_06.md и далее. В шапке каждого — «проект локальной формы». Не класть в папку проверяющему как «утверждено Минтрудом».

32. Позиция проверяющего

Проверяющий не спорит с достоинством. Он смотрит: пробы, температура, журналы, соответствие меню факту, диета по назначению, поточность.

Ответ — папка, не формула «запрета нет». Если практика не закреплена локально, она выглядит как отступление от раскладки.

Ст. 6.6 КоАП — про организацию питания населения. Два вторых при закрытом контуре не состав. Имитация проб — состав.

Если инспектор не принял логику — карточка 03_семинарский_пакет/21_если_инспектор_не_принял.md: комплект, пункты СанПиН, не спор о философии.

33. Распределение ответственности

Кто	За что отвечает	Чего не делает
Директор	Система контроля, приказы, письмо учредителю, остановка пилота	Не варит кашу и не ставит диагноз
Врач / психиатр	Стол, текстура, таблица взаимодействий, эскалация отказа	Не проектирует линию раздачи
Диетсестра / раскладка	Пары, нормы, перечень выбора	Не отменяет кофе «сама»

Кто	За что отвечает	Чего не делает
Повар	Два варианта, маркировка, пробы	Не решает, «кому полезно»
Смена	Предложение выбора, журнал, помощь за столом	Не ограничивает порцию без назначения
Контрактная служба	Спецификация пар, ТЗ аутсорсера	Не подменяет клинику

Делегирование исполнения не снимает ответственность директора за работающий контроль.

34. Совет жителей

Совет — канал воли, не декорация. Дегустации протоколируются. Меню праздников и сезонность — через совет. Если учреждение — опекун, совет и независимый канал обращений снижают конфликт интересов.

Это рекомендация. В части регионов советы по питанию уже сидят в актах субъекта (пример ДДСОЛ / распоряжение МО). Читайте свой.

35. Пилот 90 дней

Зачем 90. Две недели — новизна. Дальше видно ритм, труд, конфликты.

Дни 1–14. Приказ, замер «до», опрос, инструктаж, письмо учредителю. Кухню не трогать.

Дни 15–75. М1: два варианта второго на обед, 2–3 дня в неделю, одно отделение 20–35 человек, одна смена. Еженедельная планёрка на 15 минут. Три корзины: смена / кухня / администрация.

Дни 76–90. Панель «после» против «до». Совет жителей. Решение: расширить / закрепить точку / свернуть с причинами. Свёрнутый пилот с протоколом — управление, не позор.

Стоп-критерии (немедленно): рост отказов от еды; санитарные нарушения новой линии; клиническое заключение врача.

Что пилот доказывает. Исполнимость и безопасность.

Чего не доказывает. Что выбор улучшил здоровье. Для этого нет дизайна.

Смещения: Хоторн, сезон, смена, возврат к среднему после аномально плохого «замера до».

36. Карта рисков и красные линии

Риск	Линия	Что делать
Аспирация	Текстура только врач; маркировка	Список риска у сиделки
Токсичность клозапина / лития	Без самодеятельности кухни	Таблица + передачи
Голод при отказе	Три отказа → врач	Журнал замен
Фиктивный выбор	Вариант Б кончился / журналы пусты	Индикатор срыва
Имитация проб	Вторая проба не отобрана	Паспорт ёмкости
Конфликт опекуна- учреждения	Питание «по усмотрению»	Правила на всех
Сентябрь 2026	Ссылки на 3590 после 01.09	Перепривязка
Очередь	Помощь не готова	Не выдавать вперёд
Аутсорсер	Выбора нет в ТЗ	Не ждать чуда
Регресс после энтузиаста	Журнал «для проверки»	Ритм в приказе

37. Четырнадцать возражений директоров

Короткие ответы. Развёртка — 03_семинарский_пакет/14_возражения.md.

1. **Запретят.** Покажите папку и пункты СанПиН. Запрета на два блюда нет.
2. **Нет денег.** Замер. Пары. Не обещать полный переход бесплатно.
3. **Нет людей.** М1, одно отделение, заказ накануне.
4. **Недееспособные не выбирают.** Ст. 29 ГК — мнение учитывать.
5. **Не говорят.** Показ двух порций.
6. **Разболеются / растолстеют.** Рамка врача, не отмена выбора.
7. **Очереди.** Поток и заказ, не отказ от пары.
8. **Повар не справится.** Пары проектирует кухня.

9. **Аутсорсер не даст.** ТЗ.
10. **У нас и так 14 дней меню.** Это цикл, не выбор.
11. **Прокуратура.** Пробы важнее философии.
12. **Родственники будут диктовать.** Биография учитывается, не заменяет жителя.
13. **У нас всё нормально.** Семь дней замера.
14. **Вы сами это едите?** Если директор не ел свою еду в этом месяце — сначала тарелка, потом спор.

38. Разговор с учредителем: десять вопросов

1. Готовы ли согласовать пилот М1 на одном отделении на 90 дней без смены сметы?
2. Какой канал уведомления закрывает претензию «самоуправство»?
3. Как в нашем субъекте читается 520н — рекомендация или есть свой обязательный акт?
4. Что делать с конфликтом «учреждение = опекун» в решениях о питании?
5. Какая сырьевая строка у дома и можно ли её видеть ежеквартально?
6. Аутсорсинг: впишем ли выбор в следующее ТЗ?
7. Какие стоп-критерии пилота учредитель принимает заранее?
8. Готов ли включить в показатели доступность выбора, а не «% довольных»?
9. 01.09.2026: кто подписывает перепривязку ППК к 4282-26?
10. Если пилот свернём — примете отчёт с причинами как результат?

39. Достоверность данных (анти-slop)

Четыре класса: норма / толкование / рекомендация / проект формы.

Запрещено в этом пакете: «как известно»; процент отходов РФ; «Campforts доказал меню»; «4282-26 уже действует» (на 26.08 — нет); «520н обязателен»; «330н на СОСО»; «грейпфрут и клозапин» как одна связка; «74 %» без источника и без оговорки дома.

Полная таблица — FASTCHECK.md.

40. Аутсорсинг питания

Если плита не ваша, вариативность живёт в спецификации. Восемь строк ТЗ: два варианта позиций; текстурные линии по назначению; журнал заказа; журнал замен; пробы каждого варианта; температура на последней выдаче; отчёт по срывам Б; участие в дегустации совета.

Контроль приёмки — акты, не дегустация директора раз в год.

Календарь: закладывать строки **до** объявления закупки, не после жалоб жителей.

41. Обращение к отрасли и Минтруду

Не прошу новый федеральный закон о меню. Рамка 3185-1, 442-ФЗ, СанПиН, 520н уже позволяет М1.

Прошу три вещи, которые не ломают субъекты:

1. Ясно сказать отрасли: вариативность внутри раскладки **не** нарушение, если закрыт санитарный контур.
2. В методичках развести 520н (рекомендация) и СанПиН (обязанность).
3. Не вводить обязательную вариативность без переходного периода — получим фиктивные журналы.

Два показателя, которые можно считать дёшево: доля приёмов с реально доступным выбором; замер отходов по методике дома. Не «счастье».

42. Следующие шаги после 26.08

Для зала: один обед, одно отделение, одна неделя замера.

Для юриста дома: перепривязка к 4282-26 к утру 01.09.

Для врача: таблица на посту.

Для меня и Тимура: не смешивать 223 и 44 в советах коллегам.

Для отрасли: кто внедрил — опубликовать панель чисел, не только новость.

43. Заключение: ответ на вопрос введения

Вопрос был: как дать выбор, не ломая безопасность, клинику и закупку.

Ответ. Не рестораном. Не новой строкой «на инновации». Архитектурой: врач рисует красные линии; кухня держит пару в одной сырьевой группе; смена фиксирует слово, жест и отказ; локальный акт делает это правилом дома, а не энтузиазмом заведующей; закупка знает про пары до торгов. СанПиН с 1 сентября сменит нумерацию пунктов, не отменит эту логику и не создаст обязанности выбора.

В Серафимовском заказное питание уже в правилах дома — локально, с названной ценой и названными пределами. Тимур Нурбаев ведёт другой закон закупки; мы в его доме, и я не рассказываю ему, как проводить аукцион.

Последнее слово — не «внедряйте». Измеряйте. Без семи дней замера у вас мнение о столе. С замером — знание. Из знания растёт пилот. Из пилота — либо расширение, либо честный отказ. Оба исхода лучше фиктивного журнала.

44. Библиография

См. отдельный файл [BIBLIOGRAPHY.md](#) — ГОСТ Р 7.0.5-2008, только проверенные 24.08.2026 позиции.

Счётчики «115 цитирований» и «126 источников» относятся к другой сборке полного руководства (01_доклад/) и сюда не переносятся.